

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Insertion of Tension Free Vaginal Tape (TVT) for Stress Incontinence and Cystoscopy

إدخال الشريط المهبل الذي لا يسبب أي ضغط
لعلاج سلس البول الناتج عن الإجهاد ولمنظار
المثانة البولية

A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required?

☐ Yes ☐ No

If Yes, is an Interpreter present?

☐ Yes ☐ No

B. Condition and treatment

The doctor has explained that you have the following condition: (Doctor to document in patient's own words)

This condition requires the following procedure. (Doctor to document - include site and/or side where relevant to the procedure)

The following will be performed:

The damaged ligaments are replaced by a 1cm wide tape of synthetic mesh. This tape returns the support for the urethra (this is the tube that leads from the bladder to the outside) to the surrounding tissues. This is routinely followed by looking into the bladder to make sure no damage has been done (Cystoscopy).

C. Risks of an insertion of tension free vaginal tape (TVT) and Cystoscopy

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Bleeding could occur and may require a return to the operating room.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.

Specific risks:

The success rate is very high (9 in 10 women). The long-term success rate is not yet known.

- Overactive bladder/urge incontinence after the operation is 6%. You may need to go the toilet a lot, may have sudden urges to pass urine. These symptoms are usually managed by bladder retraining and drug therapy. A small proportion of patients will continue to have long-standing bladder symptoms despite treatment.
- Urine retention. Problems with passing urine are uncommon. This rarely needs long term management. If this happens, the tape may be divided through the vaginal cut. (5%) There is a small risk of the urinary incontinence returning. (10%)
- Infection requiring antibiotics
- Urethral Injury (the tube that leads from bladder to the

☐ نعم ☐ لا
☐ نعم ☐ لا

أ. المترجم / الاحتياج الثقافي
هل توجد حاجة لخدمات الترجمة ؟
إذا كانت الإجابة بنعم ، فهل يوجد مترجم ؟

ب. الحالة المرضية والعلاج
لقد قام الطبيب بشرح حالتك المرضية لك وأنت تعاني من : (يقوم الطبيب بالتوثيق بما يلائم لغة ومفردات المريض)

تتطلب هذه الحالة المرضية الإجراء الطبي التالي:
(يقوم الطبيب بالتوثيق ويشمل ذلك موضع و/ أو الجهة المتعلقة بالإجراء)

سيتم الإجراء التالي :
استبدال الأربطة المتضررة بشبكة من شريط صناعي بعرض 1 سنتيمتر. يعيد هذا الشريط الدعم لقناة مجرى البول (الأنبوب الواصل بين المثانة البولية وخارج الجسم) مع الأنسجة المجاورة لها . ويتم ذلك بشكل روتيني مع إجراء منظار للمثانة البولية للتأكد من عدم تضررها.
ج. مخاطر إدخال الشريط المهبل الذي لا يسبب أي ضغط لعلاج سلس البول الناتج عن الإجهاد ولمنظار المثانة البولية
يتضمن هذا الإجراء مخاطر ومضاعفات تشمل ولا تقتصر على ما يلي:

مخاطر عامة:

- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه.
- قد يحدث انغلاق لمناطق صغيرة في الرئة مما يزيد من مخاطر الإصابة بالتهاب في الصدر وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مما يسبب ألم وتورم في الساق وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- احتمال الوفاة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر محددة:

- معدل نجاح الإجراء عال جداً (9 من بين كل 10 نساء) . معدل النجاح على المدى البعيد غير معروف إلى الآن.
- يزداد نشاط المثانة البولية بعد الإجراء بنسبة (6%) وقد تضطرب للذهاب بكثرة إلى دورة المياه . قد تشعرين برغبة مفاجئة في التبول وقد يتسرب البول . يمكن السيطرة على هذه الأعراض بإعادة تمرين المثانة البولية بالأدوية . وتستمر أعراض المثانة البولية لدى نسبة بسيطة من المرضى لفترة طويلة بالرغم من تناول العلاج.
- مشاكل التبول غير شائعة . من النادر أن يتطلب ذلك علاج لفترة طويلة. وعند حدوث ذلك فقد يتم تقسيم الشريط عبر الشق المهبل . (5%) هناك نسبة خطر بسيطة بعودة سلس البول. (10%)
- حدوث عدوى تتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى.
- يندر حدوث نزيف مفرط.
- في حالة السمنة المفرطة . تزداد مخاطر الإصابة بعدوى والتهاب الجرح والصدر ومضاعفات في القلب والرئة وجلطات الأوعية الدموية.
- تزداد عدوى الجرح والصدر ومضاعفات القلب والرئة والتخثرات الدموية

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

outside)

- Bladder perforation (5%)
- The tape may erode through the urethra in the years after the operation. This would need repair of the urethra and a catheter insertion. (1-2 %)

D. Significant Risks and Procedure Options

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

E. Risks of not having this procedure

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

F. Anesthetic

This procedure may require an anaesthetic. (Doctor to document type of anaesthetic discussed).

G. Patient Consent

I acknowledge that the doctor has explained:

- My medical condition and the proposed procedure, including additional treatment if the doctor finds something unexpected. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- The anaesthetic required for this procedure. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- Other relevant procedure/treatment options and their associated risks.
- My prognosis and the risks of not having the procedure.
- That no guarantee has been made that the procedure will improve my condition even though it has been carried out with due professional care.
- Tissues and blood may be removed and could be used for diagnosis or management of my condition, stored and disposed of sensitively by the hospital.
- If immediate life-threatening events happen during the procedure, they will be treated based on my discussions with the doctor or my Acute Resuscitation Plan.
- A doctor other than the Consultant may conduct the procedure. I understand this could be a doctor undergoing further training.

I have been given the following Patient Information Sheet/s:

- في الأوردة لدى المدخنات.
- قد يحدث ضرر أحياناً لقناة مجرى البول (الأنبوب الواصل بين المثانة وخارج الجسم).
- قد يحدث أحياناً ضرر للمثانة البولية. (5 %)
- بعد سنوات من الإجراء قد يسبب الشريط تآكلاً في جدار قناة مجرى البول و يتطلب ذلك إصلاح قناة مجرى البول ووضع قسطرة بولية لأسبوعين. (1-2 %)

د . مخاطر كبيرة وهامة وخيارات الإجراء
(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد وتدوين ذلك في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

هـ . مخاطر عدم الخضوع للإجراء
(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، وتدوين ذلك في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

و . التخدير
قد يتطلب القيام بهذا الإجراء الخضوع للتخدير. (يقوم الطبيب المعالج بتدوين نوع التخدير الذي تمت مناقشته مع المريض)

ز . إقرار المريض
أقر بأن الطبيب قد شرح لي :

- حالتي المرضية والإجراء المقترح بما في ذلك الإجراءات العلاجية الإضافية في حالة اكتشاف الطبيب لأمر لم يكن متوقعاً . وأقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- التخدير المطلوب لهذا الإجراء . أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- الخيارات الإجرائية الطبية \العلاجية الأخرى ذات الصلة والمخاطر المترتبة عليها.
- المسار الطبيعي لحالتي المرضية ومخاطر عدم القيام بالإجراء.
- عدم تقديم أي ضمانات لي بأن الإجراء سيؤدي إلى تحسن حالتي المرضية بالرغم من أن الإجراء سيتم بمهنية عالية.
- احتمالية إزالة أنسجة أو دم ،وقد يستخدمان في تشخيص أو علاج حالتي المرضية ويتم حفظها والتخلص منها عن طريق المستشفى بطريقة مهنية تراعي الأنظمة والأعراف.
- إذا حدث (لا سمح الله) ما يهدد حياتي أثناء الإجراء ، فسيتم التعامل معه حسب ما تم شرحه لي من قبل الطبيب أو حسب خطة الإنعاش المحددة لي
- قد يقوم بالإجراء طبيب آخر غير الاستشاري ، وأنا مدرك تماماً أن هذا الطبيب منخرط في برنامج تدريبي متقدم.

لقد تم إعطائي مستندات وأوراق التعليمات التالية:

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- ☐ **About Your Anaesthetic**
☐ **Epidural and Spinal Anaesthetic**
☐ **Insertion of Tension Free Vaginal Tape (TVT) and Cystoscopy**

- I was able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the proposed procedure and its risks, and my treatment options. My questions and concerns have been discussed and answered to my satisfaction.
- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this form but, preferably following a discussion with my doctor.
- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during my procedure and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.

On the basis of the above statements,

I request to have the procedure

Name of Patient:

Signature:

Date: Time:

Patients who lack capacity to provide consent

Consent must be obtained from a substitute decision maker/s in the order below.

Name of Substitute

Decision Maker/s:

Signature:

Relationship to patient:

Date: Time:

Contact No:

H. Doctor/designee statement

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent section (G) and I am of the opinion that the patient/substitute decision-maker has understood the information.

Name of

Doctor/delegate:

Designation:

Signature:

Date: Time:

Witnesses (for the above signature)

1) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

2)) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

- ☐ نوعية التخدير المقدم لي
☐ التخدير النصفي (التخدير الشوكي أو تخدير فوق الجافية)
☐ إدخال الشريط المهبل الذي لا يسبب أي ضغط لعلاج سلس البول الناتج عن الإجهاد ولمنظار المثانة البولية
- منحني طبيبي الفرصة لطرح أسئلتى والتعبير عن مخاوفي واهتماماتي المتعلقة بحالتي المرضية والإجراء المقترح ومخاطره والخيارات المتاحة لعلاجي وقد تم الرد على استفساراتي ومخاوفي بصورة مرضية.
 - أتفهم أن من حقى تغيير رأيي في أي لحظة حتى بعد توقيعى لهذا النموذج ، ولكن من الأفضل أن يتم ذلك بعد مناقشته مع طبيبي.
 - أتفهم أنه قد يتم خلال وكجزء من الإجراء أخذ صور طبية أو تسجيل مقاطع فيديو يتعلق بالمرض وأن ذلك سيتم خلاله، وأن هذه الصور والمقاطع المصورة ستساعد الطبيب على اختيار أنسب طرق العلاج.

وبناء على ما تقدم، فإنني أطلب الخضوع للإجراء الطبي

اسم المريض:

التوقيع:

التاريخ: الوقت:

المرضى فاقد القدرة على إعطاء الإقرار

يتم الحصول على الإقرار من قبل شخص/ أشخاص بديل مناسب ينوب عنه ويملك المقدرة على اتخاذ القرار على النحو الموضح أدناه.

اسم من ينوب أو ينوبون عن المريض في اتخاذ القرار:

التوقيع:

صلة القرابة بالمريض:

التاريخ: الوقت:

رقم الاتصال:

ح . إفادة الطبيب أو من ينوب عنه

لقد شرحت للمريض كل النقاط المذكورة سابقاً في الفقرة (ز) إقرار المريض وأنا على ثقة بأن المريض أو من ينوب عنه قد فهم جميع المعلومات المقدمة له .

اسم الطبيب أو من ينوب عنه:

اللقب:

التوقيع:

التاريخ: الوقت:

اسم الشاهد (على هذا التوقيع أعلاه)

1) الاسم: _____ التوقيع: _____

التاريخ: الوقت:

2) الاسم: _____ التوقيع: _____

التاريخ: الوقت: